

FRONT



PATIENT INFORMATION LEAFLET

Device Type: Intraocular Lens (Aphakic)

Introduction

Cataract is a condition that becomes more common as we age. A cataract forms over time as the eye's natural lens stiffens and gradually becomes opaque. People with cataracts experience 'cloudy vision'. Color become less vivid over time, and there is often increased sensitivity to light. For example, someone with cataract will likely experience an increased amount of glare from oncoming car headlights at night. Without treatment, cataract will eventually block light passing through the eye and cause blindness.



Fig. 1: The anatomy of the eye

How does cataract impact your vision?

A cataract affects the eye's natural lens, which is called the crystalline lens. Normally, this lens helps focus light onto the back of the eye (the retina) so we can see clearly. The lens is flexible and changes shape to help us focus on things both near and far. When we look at something close, the lens curves; when we look at something far away, it flattens. This ability of the lens to adjust for different distances is called "accommodation."

As we get older, the lens becomes less flexible, making it harder to focus on close objects—a condition called presbyopia, which can make reading small print difficult. A cataract adds another problem: the lens, which is normally clear, gradually becomes cloudy. This makes vision blurry over time. When cataracts start to affect vision, the cloudy natural lens needs to be removed and replaced with an artificial lens through surgery.

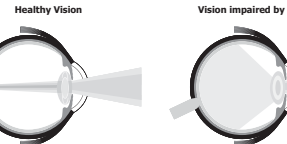


Fig. 2: Vision simulation without and with cataract

What is an Intraocular Lens (IOL)?

Intraocular lenses are artificial lenses used in modern cataract surgery. They are implanted in the capsular bag to replace the human crystalline lens, which is clouded by the cataract. Intraocular lenses are indicated for adult patients 18 years of age and above with cataract.

There has been significant advancement in materials and designs for intraocular lenses. We offer Intraocular lenses of different material types which includes: polymethyl methacrylate (PMMA), acrylic materials such as hydrophobic (repelling water) acrylic and hydrophilic (absorbing water) acrylic.



Fig. 3: Representative image of an Artificial Intraocular Lens

Different types and performance of the IOL

There are different types of lenses currently available. Your eye doctor will discuss which type of lens is best for you. Treatment options other than new permanent lens include glasses with thick lenses and contact lenses. Discuss potential risks and benefits of your treatment options with your eye doctor.

- **Monofocal IOLs**
- Monofocal IOLs restore clear distance vision. This means that you should see well when you go to a ball game or read distant signs. You will probably need glasses for near vision tasks such as reading a book, writing, or doing crafts. You may also need glasses for intermediate vision activities such as working on a computer, putting on make-up, or shaving.
- **Multifocal IOLs**
- All IOLs generally are designed for distance vision. However, multifocal IOLs are also designed to improve near and intermediate vision compared to a monofocal lens. This means that you should see well whether you go to a ball game or read a book. Multifocal lenses have different powers for near vision, based on your lifestyle needs. Overall, you may wear glasses less often for daily tasks. However, the sharpness of your vision may also decrease compared to a monofocal lens. This is especially the case under poor visibility conditions such as dim light or fog. You may also notice more halos (rings around light) or glare (reflected light, making it difficult to see). Both are common with multifocal IOLs.
- **EDoF (Extended Depth of Focus) IOLs**
- It enables sharp vision ranging from far to intermediate distances, such as a computer monitor. For close-up activities such as reading fine print and precision work, patients implanted with EDoF lenses may need to wear reading glasses. However, they will experience fewer visual disturbances at night, which are sometimes caused by bright light sources with multifocal IOLs. EDoF lenses thus present an attractive combination of more spectacle independence than monofocal IOLs and fewer potential side effects than multifocal IOLs.
- **Toric IOLs**
- Toric IOLs restore clear distance vision for patients with astigmatism. Astigmatism is blurred or distorted vision caused by an irregularly shaped cornea. If you have astigmatism, a Toric IOL may be the right choice for you.
- **Multifocal Toric IOLs**
- Multifocal toric intraocular lenses are designed to correct astigmatism while also improving vision at multiple distances, including far, intermediate, and near. This may allow you to perform many daily activities, such as reading, using a computer, or seeing distant objects, with reduced dependence on glasses.
- What to expect before cataract surgery**
- You will be evaluated before surgery. This includes checking for any eye diseases and measuring your eye for the correct lens power. If you wear contact lenses, your eye doctor may ask you to stop wearing them before being tested. Tell your eye doctor if you have any health conditions that may affect your surgery or vision. Examples include high blood pressure, diabetes, and heart disease. Give your eye doctor a current list of your medications. Plan to have someone else drive you home after surgery.
- what to expect during cataract surgery**
- Cataract surgery is typically performed as an outpatient procedure. You will be given anesthesia in the form of eye drops to numb your eye. Typically, you will be fully awake during the surgery. Expect to feel little or no discomfort. Your eye doctor will use a microscope to have a magnified view of your eye. Your natural lens sits in a bag-like structure called the lens capsule. The lens capsule is located just behind the colored part of your eye (iris). A small incision is made in the outer surface of the eye. The eye doctor inserts a tiny probe through this opening to break up the cataract lens. Your eye doctor then uses a small vacuum-like device to remove the cataract pieces from your eye. Now there will be space for the IOL to be placed in your eye, to replace natural lens that your eye doctor has just removed. Your doctor will insert the IOL through the same tiny incision. When the surgery is complete, your eye doctor may place a protective patch or shield over your eye.



NOTICE D'INFORMATION DESTINÉE AU PATIENT

Type de dispositif : Lentille intraoculaire (aphaque)

Introduction

La cataracte est une affection qui devient plus fréquente avec l'âge. Une cataracte se développe au fil du temps lorsque le cristallin naturel de l'œil se rigidifie et devient progressivement opaque. Les personnes atteintes de cataracte présentent une vision « trouble ». Les couleurs deviennent moins vives avec le temps et une sensibilité accrue à la lumière est souvent observée. Par exemple, une personne atteinte de cataracte ressentira probablement un éblouissement plus important causé par les phares des véhicules venant en sens inverse la nuit. Sans traitement, la cataracte finira par bloquer le passage de la lumière à travers l'œil et entraînera la cécité.

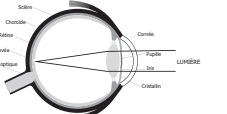


Fig. 1 : Anatomie de l'œil

Comment la cataracte affecte-t-elle votre vision ?

La cataracte affecte le cristallin naturel de l'œil, appelé cristallin. Normalement, ce cristallin aide à focaliser la lumière sur le fond de l'œil (la rétine) afin que nous puissions voir clairement. Le cristallin est souple et change de forme pour nous aider à faire la mise au point sur des objets proches comme éloignés. Lorsque nous regardons un objet proche, le cristallin se courbe ; lorsque nous regardons un objet éloigné, il s'aplatit. Cette capacité du cristallin à s'adapter à différentes distances est appelée « accommodation ».

Avec l'âge, le cristallin devient moins souple, ce qui rend plus difficile la mise au point sur les objets proches — une affection appelée presbytie, qui peut rendre la lecture des petits caractères difficile. La cataracte ajoute un autre problème : le cristallin, normalement transparent, devient progressivement trouble. Cela entraîne une vision floue au fil du temps. Lorsque la cataracte commence à affecter la vision, le cristallin naturel opacifié doit être retiré et remplacé par une lentille artificielle au moyen d'une intervention chirurgicale.

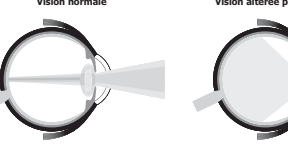


Fig. 2 : Simulation de la vision sans et avec cataracte

Qu'est-ce qu'une lentille intraoculaire (LIO) ?

Les lentilles intraoculaires sont des lentilles artificielles utilisées dans la chirurgie moderne de la cataracte. Elles sont implantées dans le sac capsulaire pour remplacer le cristallin humain devenu opaque à cause de la cataracte. Les lentilles intraoculaires sont indiquées chez les patients adultes âgés de 18 ans et plus atteints de cataracte.

Les matériaux et les conceptions des lentilles intraoculaires ont connu des avancées considérables. Nous proposons des lentilles intraoculaires fabriquées à partir de différents types de matériaux, notamment le polyméthacrylate de méthyle (PMMA) ainsi que des matériaux acryliques tels que l'acrylique hydrophobe (repoussant l'eau) et l'acrylique hydrophile (absorbant l'eau).



Fig. 3 : Image représentative d'une lentille intraoculaire artificielle

Différents types de LIO et leurs performances

Il existe actuellement différents types de lentilles disponibles. Votre ophtalmologiste discutera avec vous du type de lentille le mieux adapté à votre situation. Les autres options de traitement qu'une nouvelle lentille permanente comprennent les lunettes à verres épais et les lentilles de contact. Discutez des risques et des avantages potentiels de vos options de traitement avec votre ophtalmologiste.

- **LIO monofocales**
- Les LIO monofocales restaurent une vision nette de loin. Cela signifie que vous devriez bien voir lorsque vous assistez à un événement sportif ou lorsque vous lisez des panneaux éloignés. Vous aurez probablement besoin de lunettes pour les activités de vos loisirs telles que la lecture, l'écriture ou les loisirs créatifs. Vous pourriez également avoir besoin de lunettes pour les activités de vision intermédiaire, comme travailler sur un ordinateur, vous maquiller ou vous raser.
- **LIO multifocales**
- Toutes les LIO sont généralement conçues pour la vision de loin. Cependant, les LIO multifocales sont également conçues pour améliorer la vision de près et intermédiaire par rapport à une lentille monofocale. Cela signifie que vous devriez bien voir aussi bien lorsque vous assistez à un événement sportif que lorsque vous lisez un livre. Les lentilles multifocales offrent différentes puissances pour la vision de près, en fonction de votre mode de vie et de vos besoins. Globalement, vous pourriez porter des lunettes moins souvent pour les tâches quotidiennes. Cependant, la netteté de votre vision peut être réduite par rapport à celle obtenue avec une lentille monofocale. Cela est particulièrement vrai dans des conditions de visibilité réduite, comme une faible luminosité ou le brouillard. Vous pouvez également remarquer davantage de halos (anneaux autour des sources lumineuses) ou d'éblouissements (lumière réfléchie rendant la vision plus difficile). Ces phénomènes sont fréquents avec les LIO multifocales.
- **LIO EDoF (profondeur de champ étendue)**
- Les LIO à profondeur de champ étendue permettent une vision nette allant de loin jusqu'à des distances intermédiaires, comme la visualisation d'un écran d'ordinateur. Pour les activités de près telles que la lecture de petits caractères ou les travaux de précision, les patients porteurs de lentilles EDoF peuvent avoir besoin de porter des lunettes de lecture. Toutefois, ils ressentiront moins de perturbations visuelles nocturnes, parfois provoquées par les sources lumineuses intenses chez les porteurs de LIO multifocales. Les lentilles EDoF représentent ainsi une combinaison intéressante offrant une plus grande indépendance vis-à-vis des lunettes que les LIO monofocales, tout en présentant moins d'effets secondaires potentiels que les LIO multifocales.
- **LIO toriques**
- Les LIO toriques restaurent une vision nette de loin chez les patients présentant un astigmatisme. L'astigmatisme correspond à une vision floue ou déformée causée par une cornée de forme irrégulière. Si vous souffrez d'astigmatisme, une LIO torique peut constituer le bon choix pour vous.
- **LIO multifocales toriques**
- Les lentilles intraoculaires multifocales toriques sont conçues pour corriger l'astigmatisme tout en améliorant la vision à plusieurs distances, notamment de loin, à distance intermédiaire et de près. Elles peuvent vous permettre d'effectuer de nombreuses activités quotidiennes, telles que la lecture, l'utilisation d'un ordinateur ou l'observation d'objets éloignés, avec une dépendance réduite aux lunettes.

À quoi s'attendre avant une chirurgie de la cataracte

Vous serez examiné avant l'intervention chirurgicale. Cet examen comprend la recherche d'éventuelles maladies oculaires et la mesure de votre œil afin de déterminer la puissance correcte de la lentille à implanter. Si vous portez des lentilles de contact, votre ophtalmologiste pourra vous demander d'arrêter de les porter avant les examens. Informez votre ophtalmologiste de tout problème de santé susceptible d'influencer votre intervention ou votre vision. Parmi les exemples figurent l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques. Fournissez à votre ophtalmologiste une liste à jour de tous les médicaments que vous prenez. Prévoyez qu'une autre personne vous accompagne à votre domicile après l'intervention chirurgicale.



PATIENTENINFORMATIONSBLETT

Produkttyp: Intraokularlinse (aphak)

Einführung

Der Graue Star (Katarakt) ist eine Erkrankung, die mit zunehmendem Alter häufiger auftritt. Ein Katarakt entwickelt sich im Laufe der Zeit, wenn die natürliche Linse des Auges steifer wird und allmählich eintrübt. Menschen mit Katarakt erleben eine „verschommene“ Sicht. Farben wirken mit der Zeit weniger lebendig, und häufig besteht eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Beispielsweise wird eine Person mit Katarakt nachts wahrscheinlich stärker durch die Scheinwerfer entgegenkommender Fahrzeuge geblendet. Unbehandelt blockiert der Katarakt schließlich den Lichteinfall ins Auge und kann zur Erblindung führen.

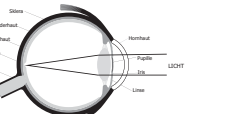


Abb. 1: Anatomie des Auges

Wie beeinflusst ein Katarakt Ihr Sehvermögen?

Ein Katarakt betrifft die natürliche Linse des Auges, die als Augenlinse (Kristalllinse) bezeichnet wird. Normalerweise hilft diese Linse dabei, das Licht auf den hinteren Teil des Auges (die Netzhaut) zu fokussieren, sodass wir klar sehen können. Die Linse ist flexibel und verändert ihre Form, um sowohl nahe als auch entfernte Objekte scharfzustellen. Wenn wir etwas in der Nähe betrachten, wölbt sich die Linse; wenn wir etwas in der Ferne betrachten, flacht sie sich ab. Diese Fähigkeit der Linse, sich an unterschiedliche Entfernungen anzupassen, wird als „Akkommodation“ bezeichnet.

Mit zunehmendem Alter wird die Linse weniger flexibel, wodurch das Fokussieren naher Objekte schwieriger wird – ein Zustand, der als Presbyopie (Alterssichtigkeit) bezeichnet wird und das Lesen kleiner Schrift erschweren kann. Ein Katarakt bringt ein weiteres Problem mit sich: Die normalerweise klare Linse wird allmählich trüb. Dadurch wird das Sehvermögen mit der Zeit unscharf. Wenn der Katarakt das Sehvermögen beeinträchtigt, muss die eingetrübte natürliche Linse operativ entfernt und durch eine künstliche Linse ersetzt werden.

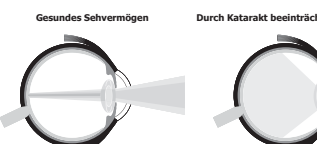


Abb. 2: Simulation des Sehens ohne und mit Katarakt

Was ist eine Intraokularlinse (IOL)?

Intraokularlinsen sind künstliche Linsen, die in der modernen Kataraktchirurgie verwendet werden. Sie werden in den Kapselsack implantiert, um die menschliche Augenlinse zu ersetzen, die durch den Katarakt eingetrübt wurde. Intraokularlinsen sind für erwachsene Patienten ab 18 Jahren mit Katarakt vorgesehen.

Bei Materialien und Designs von Intraokularlinsen werden erhebliche Fortschritte erzielt. Wir bieten Intraokularlinsen aus verschiedenen Materialtypen an, darunter Polymethylmethacrylat (PMMA) sowie Acrylmaterialien wie hydrophobes (wasserabweisendes) Acryl und hydrophiles (wasseraufnehmendes) Acryl.

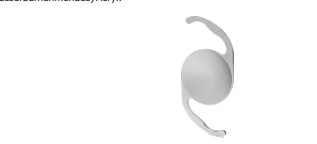


Abb. 3: Beispielsabbildung einer künstlichen Intraokularlinse

Verschiedene Arten und Leistungsmerkmale von Intraokularlinsen

Derzeit sind aktuellsten unterschiedlichen Typen von Intraokularlinsen. Ihr Augenarzt wird mit Ihnen besprechen, welcher Linsentyp für Sie am besten geeignet ist. Zu den Behandlungsoptionen neben einer neuen permanenten Linse gehören Brillen mit dicken Gläsern und Kontaktlinsen. Besprechen Sie die potenziellen Risiken und Vorteile Ihrer Behandlungsmöglichkeiten mit Ihrem Augenarzt.

- **Monofokale Intraokularlinsen**
- Monofokale Intraokularlinsen stellen ein klares Sehen in der Ferne wieder her. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise bei einer Sportveranstaltung oder beim Lesen entfernter Schilder gut sehen sollten. Für Tätigkeiten im Nahbereich wie Lesen, Schreiben oder Bastelarbeiten werden Sie wahrscheinlich eine Brille benötigen. Möglicherweise benötigen Sie auch eine Brille für Tätigkeiten im mittleren Entfernungsbereich, wie die Arbeit am Computer, das Aufladen von Make-up oder das Rasieren.
- **Multifokale Intraokularlinsen**
- Alle Intraokularlinsen sind grundsätzlich für das Sehen in der Ferne ausgelegt. Multifokale Intraokularlinsen sind jedoch zusätzlich darauf ausgelegt, das Nah- und Intermediarsehen im Vergleich zu einer monofokalen Linse zu verbessern. Das bedeutet, dass Sie sowohl bei einer Sportveranstaltung als auch beim Lesen eines Buches gut sehen sollten. Multifokale Linsen verfügen über unterschiedliche Stärken für das Nahsehen, abgestimmt auf Ihre Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse. Insgesamt benötigen Sie für alltägliche Tätigkeiten möglicherweise seltener eine Brille. Allerdings kann die Sehschärfe im Vergleich zu einer monofokalen Linse geringer sein. Dies gilt insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen, wie schwachem Licht oder Nebel. Möglicherweise bemerken Sie auch häufiger Halos (Lichtringe um Lichtquellen) oder Blendungen (reflektiertes Licht, das das Sehen erschwert). Beide Erscheinungen treten bei multifokalen Intraokularlinsen häufig auf.
- **EDoF-Intraokularlinsen (Extended Depth of Focus)**
- EDoF-Intraokularlinsen ermöglichen scharfes Sehen in der Ferne bis in den mittleren Entfernungsbereich, beispielsweise auf einem Computerbildschirm. Für Tätigkeiten im Nahbereich, wie das Lesen von Kleingedrucktem oder Präzisionsarbeiten, benötigen Patienten mit EDoF-Linsen möglicherweise eine Lesebrille. Allerdings treten bei ihnen weniger nächtliche Sehstörungen auf, die bei multifokalen Intraokularlinsen manchmal durch hohe Lichtquellen verursacht werden. EDoF-Linsen stellen somit eine attraktive Kombination aus größerer Brillenunabhängigkeit als monofokale Intraokularlinsen und weniger potenziellen Nebenwirkungen als multifokale Intraokularlinsen dar.
- **Torische Intraokularlinsen**
- Torische Intraokularlinsen stellen bei Patienten mit Astigmatismus ein klares Sehen in der Ferne wieder her. Astigmatismus ist ein verschwommenes oder verzerrtes Sehen, das durch eine unregelmäßig geformte Hornhaut verursacht wird. Wenn Sie an Astigmatismus leiden, kann eine torische Intraokularlinse die richtige Wahl für Sie sein.
- **Multifokale torische Intraokularlinsen**
- Prima dell'intervento sarete sottoposti a una valutazione. Questa comprende il controllo di eventuali patologie oculari e la misurazione dell'occhio per determinare il corretto potere diottrico della lente. Si porterete infatti a contatto, il vostro oculista potrebbe chiedervi di interrompere l'uso prima degli esami. Informate il vostro oculista di eventuali condizioni di salute che potrebbero influenzare l'intervento o la vostra vista. Alcuni esempi includono ipertensione arteriosa, diabete e malattie cardiache. Fornite al vostro oculista un elenco aggiornato dei farmaci che assumete. Organizzatevi affinché qualcuno vi accompagni a casa dopo l'intervento.

Cosa aspettarsi durante l'intervento di cataratta

L'intervento di cataratta viene generalmente eseguito in regime ambulatorio. Vi verrà somministrata un'anestesia sotto forma di collirio per anestetizzare l'occhio. Normalmente rimarerete completamente svegli durante l'intervento. Dovrete avvertire poco o nessun disagio. L'oculista utilizzerà un microscopio per ottenere una visione ingrandita del vostro occhio. Il cristallino naturale si trova in una struttura simile a una sacca chiamata capsula del cristallino. La capsula del cristallino è situata appena dietro la parte colorata dell'occhio (iride). Viene praticata una piccola incisione sulla superficie esterna dell'occhio. Attraverso questa apertura, l'oculista inserisce una piccola sonda per frammentare il cristallino opacizzato dalla cataratta.



Foglio Informativo per il Paziente

Tipo di Dispositivo: Lente Intraoculare (Afhaca)

Introduzione

La cataratta è una condizione che diventa più comune con l'avanzare dell'età. La cataratta si sviluppa nel tempo quando la lente naturale dell'occhio si irrigidisce e diventa gradualmente opaca. Le persone affette da cataratta sperimentano una visione "sfocata". I colori diventano meno vividi nel tempo e spesso si manifesta una maggiore sensibilità alla luce. Ad esempio, una persona con cataratta probabilmente percepirà un maggiore abbagliamento causato dai fari delle auto in arrivo durante la guida notturna. Senza trattamento, la cataratta finirà per bloccare il passaggio della luce attraverso l'occhio e causare cecità.

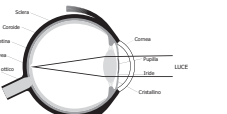


Fig. 1: Anatomia dell'occhio

In che modo la cataratta influisce sulla vista?

La cataratta colpisce il cristallino naturale dell'occhio, chiamato cristallino. Normalmente, questa lente aiuta a focalizzare la luce sulla parte posteriore dell'occhio (la retina), consentendoci di vedere chiaramente. Il cristallino è flessibile e cambia forma per aiutarci a mettere a fuoco sia gli oggetti vicini che quelli lontani. Quando osserviamo qualcosa da vicino, il cristallino si incurva; quando osserviamo qualcosa da lontano, si appiattisce. Questa capacità del cristallino di adattarsi alle diverse distanze è chiamata "accomodazione".

Con l'avanzare dell'età, il cristallino diventa meno flessibile, rendendo più difficile mettere a fuoco gli oggetti vicini: una condizione chiamata presbiopia, che può rendere difficile la lettura dei caratteri piccoli. La cataratta aggiunge un ulteriore problema: il cristallino, normalmente trasparente, diventa gradualmente opaco. Questo rende la visione sfocata nel tempo. Quando la cataratta inizia a compromettere la vista, il cristallino naturale opacizzato deve essere rimosso e sostituito con una lente artificiale mediante intervento chirurgico.

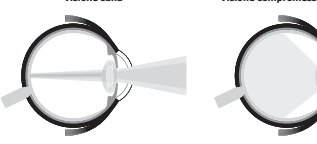


Fig. 2: Simulazione della visione senza e con cataratta

Che cos'è una Lente Intraoculare (LIO)?

Attualmente sono disponibili diversi tipi di lenti. Il vostro oculista discuterà con voi quale tipo di lente sia il più adatto alle vostre esigenze. Le alternative a una nuova lente permanente includono occhiali con lenti spesse e lenti a contatto. Discutete con il vostro oculista i potenziali rischi e benefici delle diverse opzioni di trattamento.

- **LIO Monofocali**
- Le LIO monofocali ripristinano una visione nitida da lontano. Ciò significa che dovrete vedere bene quando assistete a un evento sportivo o legistate dei segnali distanti. Probabilmente avrete bisogno di occhiali per le attività che richiedono la visione da vicino, come leggere un libro, scrivere o svolgere lavori manuali. Potreste inoltre aver bisogno di occhiali per attività a distanza intermedia, come lavorare al computer, truccarvi o radervi.
- **LIO Multifocali**
- Tutte le LIO sono generalmente progettate per la visione da lontano. Tuttavia, le LIO multifocali sono progettate anche per migliorare la visione da vicino e a distanza intermedia rispetto a una lente monofocale. Ciò significa che dovrete vedere bene sia quando assistete a un evento sportivo sia quando leggete un libro. Le lenti multifocali hanno diversi poteri per la visione da vicino, in base alle esigenze del vostro stile di vita. Nel complesso, potreste utilizzare gli occhiali meno frequentemente nelle attività quotidiane. Tuttavia, la nitidezza della visione potrebbe risultare inferiore rispetto a quella ottenuta con una lente monofocale. Questo accade soprattutto in condizioni di scarsa visibilità, come luce debole o nebbia. Potreste inoltre notare più aloni (anelli intorno alle fonti luminose) e abbagliamento (luce riflessa che rende difficile vedere chiaramente). Entrambi questi fenomeni sono comuni con le LIO multifocali.
- **LIO EDoF (Extended Depth of Focus)**
- Le LIO EDoF consentono una visione nitida dalle lunghe alle medie distanze, ad esempio su uno schermo di computer. Per attività ravvicinate come la lettura di caratteri molto piccoli o lavori di precisione, i pazienti implantati con lenti EDoF potrebbero aver bisogno di occhiali da lettura. Tuttavia, sperimenteranno meno disturbi visivi durante la notte, che talvolta possono essere causati da fonti luminose intense nelle LIO multifocali. Le lenti EDoF rappresentano quindi una combinazione vantaggiosa tra una maggiore indipendenza dagli occhiali rispetto alle LIO monofocali e un minor numero di potenziali effetti indesiderati rispetto alle LIO multifocali.
- **LIO Toriche**
- Le LIO toriche ripristinano una visione nitida da lontano nei pazienti affetti da astigmatismo. L'astigmatismo è una visione sfocata o distorta causata da una forma irregolare della cornea. Se soffrite di astigmatismo, una LIO torica potrebbe essere la scelta più adatta per voi.
- **LIO Toriche Multifocali**
- Le lenti intraoculari toriche multifocali sono progettate per correggere l'astigmatismo e contemporaneamente migliorare la visione a diverse distanze, comprese quelle lontane, intermedie e vicino. Ciò può consentirvi di svolgere molte attività quotidiane, come leggere, utilizzare un computer o vedere oggetti distanti, riducendo la dipendenza dagli occhiali.

Cosa aspettarsi prima dell'intervento di cataratta

Prima dell'intervento sarete sottoposti a una valutazione. Questa comprende il controllo di eventuali patologie oculari e la misurazione dell'occhio per determinare il corretto potere diottrico della lente. Si porterete infatti a contatto, il vostro oculista potrebbe chiedervi di interrompere l'uso prima degli esami. Informate il vostro oculista di eventuali condizioni di salute che potrebbero influenzare l'intervento o la vostra vista. Alcuni esempi includono ipertensione arteriosa, diabete e malattie cardiache. Fornite al vostro oculista un elenco aggiornato dei farmaci che assumete. Organizzatevi affinché qualcuno vi accompagni a casa dopo l'intervento.

Cosa aspettarsi durante l'intervento di cataratta

L'intervento di cataratta viene generalmente eseguito in regime ambulatorio. Vi verrà somministrata un'anestesia sotto forma di collirio per anestetizzare l'occhio. Normalmente rimarerete completamente svegli durante l'intervento. Dovrete avvertire poco o nessun disagio. L'oculista utilizzerà un microscopio per ottenere una visione ingrandita del vostro occhio. Il cristallino naturale si trova in una struttura simile a una sacca chiamata capsula del cristallino. La capsula del cristallino è situata appena dietro la parte colorata dell'occhio (iride). Viene praticata una piccola incisione sulla superficie esterna dell'occhio. Attraverso questa apertura, l'oculista inserisce una piccola sonda per frammentare il cristallino opacizzato dalla cataratta.



Folheto Informativo para o Paciente

Tipo de Dispositivo: Lente Intraocular (Afáfrica)

Introdução

A catarata é uma condição que se torna mais comum com o avançar da idade. A catarata forma-se ao longo do tempo à medida que a lente natural do olho se endurece e se torna gradualmente opaca. As pessoas com cataratas apresentam uma visão "turva". As cores tornam-se menos vivas com o tempo e existe frequentemente uma maior sensibilidade à luz. Por exemplo, uma pessoa com cataratas provavelmente experimentará um maior encandecimento provocado pelos faróis dos veículos que se aproximam durante a noite. Sem tratamento, a catarata acabará por bloquear a passagem da luz através do olho e causar cegueira.

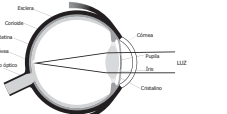


Fig. 1: Anatomia do olho

Como é que a catarata afeta a sua visão?

A catarata afeta a lente natural do olho, denominada cristallino. Normalmente, esta lente ajuda a focar a luz na parte posterior do olho (a retina), permitindo-nos ver com nitidez. O cristallino é flexível e altera a sua forma para nos ajudar a focar objetos tanto próximos como distantes. Quando observamos algo próximo, o cristallino torna-se mais curvo; quando observamos algo distante, torna-se mais plano. Esta capacidade de adaptação do cristallino a diferentes distâncias denomina-se "acomodação".

À medida que envelhecemos, o cristallino torna-se menos flexível, tornando mais difícil focar objetos próximos — uma condição denominada presbiopia, que pode dificultar a leitura de letras pequenas. A catarata acrescenta outro problema: o cristallino, normalmente transparente, torna-se gradualmente opaco. Isto provoca uma visão desfocada ao longo do tempo. Quando as cataratas começam a afetar a visão, o cristallino natural opacificado necessita de ser removido e substituído por uma lente artificial através de cirurgia.

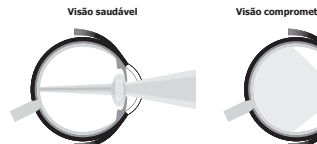


Fig. 2: Simulação da visão sem e com catarata

O que é uma Lente Intraocular (LIO)?

As lentes intraoculares são lentes artificiais utilizadas na cirurgia moderna de cataratas. São implantadas no saco capsular para substituir o cristallino humano opacificado por a catarata. As lentes intraoculares estão indicadas para pacientes adultos com idade igual ou superior a 18 anos com catarata.

Tem havido avanços significativos nos materiais e nos desenhos das lentes intraoculares. Disponibilizamos lentes intraoculares de diferentes tipos de materiais, incluindo polimetilmetacrilato (PMMA), materiais acrílicos como o acrílico hidrofóbico (repelente de água) e o acrílico hidrofílico (absorvente de água).



Fig. 3: Imagem representativa de uma Lente Intraocular Artificial

Diferentes tipos e desempenho das LIO

Atualmente existem diferentes tipos de lentes disponíveis. O seu oftalmologista irá discutir qual o tipo de lente mais adequado para si. As opções de tratamento além de uma nova lente permanente incluem óculos com lentes espessas e lentes de contacto. Discuta os potenciais riscos e benefícios das suas opções de tratamento com o seu oftalmologista.

- **LIO Monofocais**
- As LIO monofocais restauram uma visão clara a distância. Isto significa que deveria ver bem quando assiste a um evento desportivo ou lê as notícias lejantas. Provavelmente necessitará gafas para tarefas de visão cercana, como ler um livro, escrever o realizar manuais. Também pode necessitar gafas para actividades de visão intermédia, como trabalhar ao computador, maquiar-se ou fazer a barba.
- **LIO Multifocais**
- Todas as LIO são geralmente concebidas para a visão ao longe. No entanto, as LIO multifocais também são concebidas para melhorar a visão próxima e intermédia em comparação com uma lente monofocal. Isto significa que deverá ver bem tanto quando assiste a um evento desportivo como quando lê um livro. As lentes multifocais tienen diferentes potencias para a visão cercana, según las necesidades de su estilo de vida. En general, es posible que necesite usar gafas con menos frecuencia para las tareas diarias. Sin embargo, la nitidez de su visión también puede disminuir en comparación con una lente monofocal. Esto ocurre especialmente en condiciones de baja visibilidad, como luz tenue o niebla. También puede notar más alambos alrededor de las luces) o deslumbramientos (luz reflejada que dificulta la visión). Ambos fenómenos son comunes con las LIO multifocales.
- **LIO EDoF (Profundidad de Enfoque Extendida)**
- Permiten una visión nítida desde distancias lejanas hasta intermedias, como la distancia de una pantalla de ordenador. Para actividades de cerca, como leer letra pequeña o realizar trabajos de precisión, los pacientes implantados con lentes EDoF pueden necesitar gafas de lectura. Sin embargo, experimentarán menos alteraciones visuales durante la noche, que a veces son causadas por fuentes de luz intensa en las LIO multifocales. Por ello, las lentes EDoF representan una combinación atractiva de mayor independencia de las gafas que las LIO monofocales y menos efectos secundarios potenciales que las LIO multifocales.
- **LIO Tóricas**
- As LIO tóricas restauram uma visão clara a distância em pacientes com astigmatismo. El astigmatismo é uma visão borrosa o distorsionada causada por a córnea de forma irregular. Si tiene astigmatismo, una LIO tórica puede ser la elección adecuada para usted.
- **LIO Tóricas Multifocais**
- As lentes intraoculares tóricas multifocais foram concebidas para corrigir o astigmatismo e al mesmo tempo, melhorar a visão a múltiplas distâncias, incluindo longe, intermédia e perto. Isto pode permitir-lhe realizar muitas atividades diárias, como ler, utilizar um computador ou ver objetos distantes, com menor dependência de óculos.

O que esperar antes da cirurgia às cataratas

Será avaliado antes da cirurgia. Esta avaliação inclui a verificação de quaisquer doenças oculares e a medição do seu olho para determinar a potência correta da lente. Se utilizar lentes de contacto, o seu oftalmologista poderá pedir-lhe que deixe de as usar antes da realização dos exames. Informe o seu oftalmologista sobre quaisquer problemas de saúde que possam afetar a cirurgia ou a sua visão. Exemplos incluem hipertensão arterial, diabetes e doença cardíaca. Forneça ao seu oftalmologista uma lista atualizada dos medicamentos que toma. Planeie que outra pessoa o leve para casa após a cirurgia.

O que esperar durante a cirurgia às cataratas

A cirurgia às cataratas é normalmente realizada em regime ambulatorio. Ser-lhe-á administrada anestesia sob a forma de gotas oftálmicas para anestesiar o olho. Normalmente, permanecerá totalmente acordado durante a cirurgia. É expectável sentir pouco ou nenhum desconforto. O seu oftalmologista utilizará um microscópio para obter uma visão ampliada do seu olho. O seu cristallino natural encontra-se numa estrutura semelhante a um saco denominada capsula do cristallino. A capsula do cristallino está localizada imediatamente atrás da parte colorida do olho (iris). Se realiza uma pequena incisão na superfície externa do olho. O oftalmologista introduz uma pequena sonda através desta abertura para fragmentar o cristallino afetado por a catarata. A



Folleto de Información para el Paciente

Tipo de dispositivo: Lente Intraocular (Afáfrica)

Introducción

La catarata es una afección que se vuelve más frecuente con la edad. Una catarata se desarrolla con el tiempo a medida que el cristallino natural del ojo se endurece y se vuelve gradualmente opaco. Las personas con cataratas experimentan una visión "nublada". Los colores se vuelven menos vivos con el tiempo y suele haber una mayor sensibilidad a la luz. Por ejemplo, una persona con cataratas probablemente experimentará un mayor deslumbramiento causado por los faros de los vehículos que se aproximan durante la noche. Sin tratamiento, la catarata acabará bloqueando el paso de la luz a través del ojo y provocará ceguera.

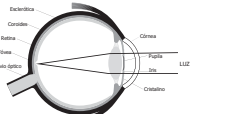


Fig. 1: Anatomía del ojo

¿Cómo afecta la catarata a su visión?

La catarata afecta al cristallino natural del ojo. Normalmente, este cristallino ayuda a enfocar la luz sobre la parte posterior del ojo (la retina) para que podamos ver con claridad. El cristallino es flexible y cambia de forma para ayudarnos a enfocar objetos tanto cercanos como lejanos. Cuando observamos algo cercano, el cristallino se curva; cuando observamos algo lejano, se aplan. Esta capacidad del cristallino para ajustarse a diferentes distancias se denomina "acomodación".

A medida que envejecemos, el cristallino se vuelve menos flexible, lo que dificulta enfocar objetos cercanos; esta condición se denomina presbicia y puede dificultar la lectura de textos con letra pequeña. La catarata añade otro problema: el cristallino, que normalmente es transparente, se vuelve gradualmente opaco. Esto provoca una visión borrosa con el tiempo. Cuando las cataratas comienzan a afectar la visión, es necesario extraer el cristallino natural opaco y reemplazarlo por una lente artificial mediante cirugía.



Fig. 2: Simulación de la visión sin y con catarata

¿Qué es una Lente Intraocular (LIO)?

Las lentes intraoculares son lentes artificiales utilizadas en la cirugía moderna de cataratas. Se implantan en el saco capsular para sustituir el cristallino humano opacificado por la catarata. Las lentes intraoculares están indicadas para pacientes adultos de 18 años o más con cataratas. Se han producido importantes avances en los materiales y diseños de las lentes intraoculares. Ofrecemos lentes intraoculares de diferentes tipos de materiales, incluidos: polimetilmetacrilato (PMMA), materiales acrílicos como el acrílico hidrofóbico (repelente al agua) y el acrílico hidrofílico (absorbente de agua).



Fig. 3: Imagen representativa de una lente intraocular artificial

Diferentes tipos y rendimiento de las LIO

Actualmente existen diferentes tipos de lentes disponibles. Su oftalmólogo le explicará qué tipo de lente es la más adecuada para usted. Discutirá con usted las opciones de tratamiento distintas de una nueva lente permanente incluyen gafas con lentes gruesas y lentes de contacto. Comente con su oftalmólogo los posibles riesgos y beneficios de las distintas opciones de tratamiento.

- **LIO Monofocales**
- Las LIO monofocales restauran una visión clara a distancia. Esto significa que debería ver bien cuando asista a un evento deportivo o le las señales lejanas. Probablemente necesitará gafas para tareas de visión cercana, como leer un libro, escribir o realizar manuales. También puede necesitar gafas para actividades de visión intermedia, como trabajar con un ordenador, maquillarse o afeitarse.
- **LIO Multifocales**
- Todas las LIO están generalmente diseñadas para la visión de lejos. Sin embargo, las LIO multifocales también están diseñadas para mejorar la visión de cerca e intermedia en comparación con una lente monofocal. Esto significa que debería ver bien tanto cuando asista a un evento deportivo como cuando lee un libro. Las lentes multifocales tienen diferentes potencias para la visión cercana, según las necesidades de su estilo de vida. En general, es posible que necesite usar gafas con menos frecuencia para las tareas diarias. Sin embargo, la nitidez de su visión también puede disminuir en comparación con una lente monofocal. Esto ocurre especialmente en condiciones de baja visibilidad, como luz tenue o niebla. También puede notar más alambos alrededor de las luces) o deslumbramientos (luz reflejada que dificulta la visión). Ambos fenómenos son comunes con las LIO multifocales.
- **LIO EDoF (Profundidad de Enfoque Extendida)**
- Permiten una visión nítida desde distancias lejanas hasta intermedias, como la distancia de una pantalla de ordenador. Para actividades de cerca, como leer letra pequeña o realizar trabajos de precisión, los pacientes implantados con lentes EDoF pueden necesitar gafas de lectura. Sin embargo, experimentarán menos alteraciones visuales durante la noche, que a veces son causadas por fuentes de luz intensa en las LIO multifocales. Por ello, las lentes EDoF representan una combinación atractiva de mayor independencia de las gafas que las LIO monofocales y menos efectos secundarios potenciales que las LIO multifocales.
- **LIO Tóricas**
- Las LIO tóricas restauran una visión clara a distancia en pacientes con astigmatismo. El astigmatismo es una visión borrosa o distorsionada causada por a córnea de forma irregular. Si tiene astigmatismo, una LIO tórica puede ser la elección adecuada para usted.
- **LIO Tóricas Multifocales**
- Las lentes intraoculares tóricas multifocales están diseñadas para corregir el astigmatismo y, al mismo tiempo, mejorar la visión a múltiples distancias, incluyendo la lejana, la intermedia y la cercana. Esto puede permitirle realizar muchas actividades cotidianas, como leer, utilizar un ordenador o ver objetos distantes, reduciendo la dependencia de las gafas.

Qué esperar antes de la cirugía de cataratas

Será evaluado antes de la cirugía. Esto incluye la comprobación de posibles enfermedades oculares y la medición de su ojo para determinar la potencia correcta de la lente. Si utiliza lentes de contacto, su oftalmólogo puede pedirle que deje de usarlas antes de realizar las pruebas. Informe a su oftalmólogo si padece alguna afección médica que pueda afectar a la cirugía o a su visión. Algunos ejemplos son la hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades cardíacas. Proporcione a su oftalmólogo una lista actualizada de los medicamentos que toma. Planifique que otra persona le lleve a casa después de la cirugía.

Qué esperar durante la cirugía de cataratas

La cirugía de cataratas suele realizarse como un procedimiento ambulatorio. Se le administrará anestesia en forma de gotas oftálmicas para adormecer el ojo. Normalmente permanecerá completamente despierto durante la cirugía. Puede sentir poco o ninguna molestia. Su oftalmólogo utilizará un microscopio para obtener una visión ampliada de su ojo. Su cristallino natural se encuentra dentro de una estructura similar a una bolsa denominada capsula del cristallino. La capsula del cristallino está situada justo detrás de la parte coloreada del ojo (iris). Se realiza una pequeña incisión en la superficie externa del ojo. El oftalmólogo introduce una pequeña sonda a través de esta abertura para fragmentar el cristallino afectado por la catarata. A

Rev. 01 | Artwork No. EYE-PIL-01-R1 | 09-2026

Rev. 01 | Artwork No. EYE-PIL-01-R1 | 09-2026

Rev. 01 | Artwork No. EYE-PIL-01-R1 | 09-2026

Rev. 01 | Artwork No. EYE-PIL-01-R1 | 09-2026

Rev. 01 | Artwork No. EYE-PIL-01-R1 | 09-2021

Rev. 01 | Artwork No. EYE-PIL-01-R1 | 09-2021